

Información Paciente

Nombre : Luis Gaston Castro Nuñez
Edad : 61a 5m 23d
Dirección : San Martín 10302, Villa La Cultura

Rut : 8.975.095-4
Fecha Nacto: 14/01/1961
Comuna : San Ramón

N° Archivo : 0126869
Sexo : Masculino
Teléfono : 9 9187 8655

N° Epicrisis
314283

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 02/06/2022 09:21

Días Estadía: 35

Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Egreso : 07/07/2022 20:07

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

LESION DERMICA

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

EPICRISIS MEDICA UCI

NOMBRE: LUIS GASTÓN CASTRO NÚÑEZ
RUT: 8.975.095-4
EDAD: 61 AÑOS
FI CASR: 02/06/2022
FI UCI: 02/06/2022

ANTECEDENTES:

- MÓRBIDOS: HTA. CARDIOPATÍA CORONARIA (IAM PARED INFERIOR, DES A ACD), USUARIO DE MARCAPASOS DDD ST. JUDE (POR BAV COMPLETO POST IAM), ICC FEVI 45% (ECOTT 2021 ADEMÁS CON VI DILATADO, DILATACIÓN SEVERA DE AI, IM LEVE, IT SEVERA FUNCIONAL, SIN SIGNOS DE HIPERTENSIÓN PULMONAR), FA PAROXÍSTICA EN TACO. EN EVALUACIONES DE CARDIOLOGÍA SE SOSPECHA MIOCARDIOPATÍA RESTRICTIVA.
- QUIRÚRGICOS: INSTALACIÓN DE MARCAPASOS DDD (2014).
- FÁRMACOS: ASPIRINA 100 MG, AMLODIPINO 5 MG CADA 12 H, CARVEDILOL 12.5 MG CADA 12 H, ENALAPRIL 5 MG CADA 12 H, ESPIRONOLACTONA 25 MG, FUROSEMIDA 40 MG CADA 8 H, ATORVASTATINA 40 MG, ACENOCUMAROL.
- ALERGIAS: NO.
- HÁBITOS: TABAQUISMO SUSPENDIDO HACE 10 AÑOS (IPA 50), OH (-), DROGAS (-)
- HOSPITALIZACIONES: 2014 IAM.
- VACUNAS: COVID 4 DOSIS.

HISTORIA DE INGRESO:

PACIENTE CON ANTECEDENTES DESCRITOS, SE ENCONTRABA HACE 1 MES EN CURACIONES EN APS POR ÚLCERA VENOSA DE EID. CONSULTA POR CUADRO DE 24 HORAS DE AUMENTO DE VOLUMEN EN EID, ASOCIADO A DOLOR PROGRESIVO Y SECRECIÓN PURULENTO ABUNDANTE, SIN FIEBRE NI OTROS SÍNTOMAS ASOCIADOS. AL INGRESO A UEA SE DESCRIBE CON PA 140/121, FC 81, SAT 98% AMBIENTAL, AFEBRIL, EN BUENAS CONDICIONES, PROFUNDAMENTE DESHIDRATADO, CON ABUNDANTE EXUDADO PURULENTO, ERITEMA Y EDEMA EN EID. SE ESTUDIÓ CON RADIOGRAFÍA DE PIE QUE EVIDENCIA LISIS DE FALANGE DISTAL EN 1° ORTEJO, SUGERENTE DE OSTEOMIELITIS. PRECOZMENTE EVOLUCIONA HIPOTENSO, HIPOGLICÉMICO HASTA 23, DESORIENTADO, POCO REACTIVO, CON CIANOSIS DISTAL DE EID, ACIDOSIS METABÓLICA (PH 7.1, CO2 25, BIC 8), FALLA RENAL (BUN 116,

Fecha Epicrisis : 07/07/2022 20:17

Fecha Última Actualización: 07-07-2022 20:17:45

Página 2 de 3

CREA 5.83, NA 132, K 5.6, CL 104) Y COAGULOPATÍA (INR 1.5, TTPK 47).

EVALUADO POR TMT IMPRESIONA ENFERMEDAD ARTERIAL OCLUSIVA PERIFÉRICA, COMPLICADA CON FASCEITIS NECROTIZANTE DE EID, POR LO QUE INGRESA A PABELLÓN DE URGENCIA. SE DESCRIBE FASCEITIS DESDE MUSLO HASTA DEDOS DEL PIE, CON COMPROMISO DE TODO EL PLANO ANTEROMEDIAL DEL MUSLO Y CANAL DE HUNTER, ADEMÁS DE SIGNOS ISQUÉMICOS A DISTAL Y MÚLTIPLES ÚLCERAS VENOSAS CON FLICTENAS. SE REALIZA ASEO QUIRÚRGICO, CON AMPUTACIÓN SUPRACONDÍLEA DE EID. INGRESA A UCI PARA CONTINUAR MANEJO.

EXAMEN FÍSICO:

SE RECIBE PACIENTE GRAVE, CON NAD A 0.26, PAM 60, FC 85 CONSTANTE, SAT 100%, FIO2 100%, AFEBRIL, HGT 84 SAS 1, PUPILAS ISOCÓRICAS, SIN FOCALIDAD
MUCOSAS HIDRATADAS, FRÍO A DISTAL, LLENE CAPILAR 3 SEG
RR2T SS, MP (+) SRA
ABDOMEN BD, RHA (+) SIN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL
EII SIN EDEMA NI SIGNOS DE TVP, EID CON AMPUTACIÓN SUPRACONDÍLEA REALIZADA HOY
MANO IZQUIERDA CON LESIÓN ERITEMATOSA DE 2 CM (SE DESCRIBE EXTRAVASACIÓN DE BICARBONATO PREVIAMENTE)

DIAGNÓSTICOS ACTUALES:

1. SHOCK SÉPTICO + FOM FOCO CUTÁNEO EN EVOLUCIÓN
 - FASCEÍTIS NECROTIZANTE PIE Y MUELO DERECHO
 - > S/P AMPUTACIÓN SUPRACONDÍLEA Y ASEO QUIRÚRGICO EID 02/06
 - > NUEVOS ASEOS 07/06 + ASEO/VAC 10/06 + CIERRE 14/06
 - > SOSPECHA OSTEOMIELITIS
2. INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA PARCIAL
 - NAVM VS TRAQUEOBRONQUITIS POR KPN BLEE + A.NIGER/A.FUMIGATUS EN TRATAMIENTO
 - SDRA POR SEPSIS FOCO CUTÁNEO
3. HERPES LABIAL CON EXTENSIÓN A REGIÓN PERIORBITARIA EN TRATAMIENTO
4. ELEVACIÓN PRUEBAS HEPÁTICAS EN SEGUIMIENTO, SIN FALLA HEPÁTICA AGUDA
 - OBS DILI POR ACICLOVIR + VORICONAZOL EN EVOLUCIÓN.
5. FALLA RENAL AGUDA CON REQUERIMIENTOS DE TRR
 - HD HOY.
6. CRÍTICO CRÓNICO
 - DELIRIUM
 - MIOPATÍA SEVERA PACIENTE CRÍTICO
 - ÍLEO MÉDICO EN EVOLUCIÓN
 - > NPTC
 - WEANING PROLONGADO, (P) TRAQUEOSTOMÍA.
4. ANTECEDENTES: HTA, ICC FEMR (FEVI 45%) POR CC, FA EN TACO.

EVOLUCION

PACIENTE QUE EVOLUCIONA EN LA UNIDAD, CON MÚLTIPLES INTERCURRENCIAS INFECCIOSAS Y QUIRÚRGICAS ¿ DE EVOLUCION PROLONGADA, COMPLETANDO 35 DÍAS EN LA UNIDAD.
SE MANTIENE DURANTE SU ESTADIA CON INESTABILIDAD EN LO HEMODINAMICO, ASI COMO REQUERIMIENTOS DE DVA, INDICACION TRANSFUSIONAL SEGÚN REQUERIMIENTOS.
ACTUALMENTE CON DVA A DOSIS ELEVADAS -* VEC CORREGIDO ¿ MALA PERFUSION CLINICA, - SE MANTIENEN INDICACIONES. PESE A LO QUE PERSISTEN CON TENDENCIA HIPOTENSORA.

VENTILATORIO. SIN ALTERACIONES DE INTERCAMBIO, SE MANTIENE CON FACTOR RESTRICTIVO POR EDEMA GANADO ¿ ASI COMO POR CUADRO QUIRÚRGICO. SE MANTIENE EN MODALIDAD CONTROLADA POR VOLUMEN CON VT A 6ML/KG Y FIO2 0.4 SIN POSIBILIDAD DE WEANING POR FALTA DE ESTABILIDAD.

INFECCIOSO: TTO ATB AMPLIO EN RELACION A CULTIVOS ¿ SE MANTIENE CON PARAMETROS INFLAMATORIOS ELEVADOS EN CONTEXTO DE SHOCK SEPTICO REFRACTARIO.

Fecha Epicrisis : 07/07/2022 20:17

Página 2 de 3

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 15:37

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Fecha Última Actualización: 07-07-2022 20:17:45

Página 3 de 3

DIURESIS POSITIVA DEBITO ESCASO FALLA RENAL EN TRR ¿ SEGÚN INDICACION DE NEFROLOGIA ¿ ULTIMA SESION HACE 48 HORAS. ¿ SIN URGENCIA DIALITICA ¿

QX: VAC FUNCIONAL DE DEBITO ELEVADO, AYER FUE A NUEVO ASEO LABORIOSO CON PERDIDA HEMATICA ABUNDANTE Y CAIDA DE HTO A 16. ¿ TEJIDO QUE SE APRECIA DESVITALIZADO ¿ AMPUTACION CON VAC A MUÑON. SIGNOS DE HIPOPERFUSION DE EEII IZQUIERDA ¿ PULSOS DEBILES. ESCASOS.

EN DICHO CONTEXTO Y CONSIDERANDO RESERVA FUNCIONAL ASI COMO EVOLUCION TORPIDA Y ESTADO CLINICO ACTUAL, ES QUE SE DECIDE EN CONJUNTO CON FAMILIARES ¿ MANEJO ACOTADO CON LIMITACION DE ESFUERZO TERAPEUTICO, SIN INNOVACION EN LA TERAPIA ¿ SE MANTIENEN MEDIDAS DE SOSTEN Y CONFORT, ASI COMO PERMITIENDO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR.

DESDE EL MEDIO DIA DE HOY, QUE SE PERMITE EL INGRESO EN ROTATIVA DE LOS FAMILIARES ¿ CONSTATANDO EL FALLECIMIENTO DEL PACIENTE CITADO EN LA UNIDAD A LAS 16:35 HORAS. SE HACE ENTREGA DE CERTIFICADO DE DEFUNCION.

Diagnóstico de Egreso

Shock séptico - FASCEITIS NECROTIZANTE.

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

FALLECIDO

Plan Post Alta

EGRESO A DOMICILIO

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente



Eduardo Cisternas Fuentes
Médico Tratante (Staff)